

Université de Constantine
Faculté de médecine
3^{ème} année de m médecine
Module de sémiologie de l'appareil génital féminin
Pr K. MESGHOUNI

2024

Les signes fonctionnels en gynécologie

OBJECTIFS

Reconnaître les douleurs

Reconnaître la leucorrhée

Préciser les caractéristiques sémiologiques de la leucorrhée

PLAN

I. Rappel physiologique

II. Les signes fonctionnels

II.1. Les douleurs

II. 2. Les pertes vaginales ou leucorrhées

I. Rappel physiologique

1.1. La puberté : les premiers signes de puberté apparaissent vers l'âge de 10 à 11 ans par le développement mammaire.

La première menstruation se produit deux ans après le début du développement des seins vers l'âge de 12 à 13 ans. La pilosité pubienne et axillaire se complète en 2 à 3 ans.

1.2. Le cycle menstruel : dure normalement de 28 à 30 jours, il se termine par la menstruation qui dure en moyenne 4 à 6 jours.

La quantité de sang perdue à chaque menstruation est en moyenne de 50 ml.

Abondance : 80 à 100 g par jours .Aspect : sang liquide non coagulé

Le cycle se divise en quatre phases :

— La phase pré-ovulatoire du 5^{ème} au 14^{ème} jour : c'est la phase proliférative qui est sous la dépendance des œstrogènes.

— L'ovulation : qui se situe entre le 14^{ème} et le 16^{ème} jour est provoquée par une décharge brutale de LH.

La période ovulatoire peut être déterminée sur la courbe thermique; elle est marquée par une ascension thermique : la température du matin inférieure à 37° (36 8° en moyenne) dans la période pré ovulaire s'élève au-dessus de 37° (37 2° en moyenne) au moment de l'ovulation.

— La phase post-ovulatoire : du 17^{ème} au 28^{ème} jour : c'est la phase sécrétoire qui est sous la dépendance de la progestérone et des œstrogènes.

— La menstruation : du 1^{er} au 5^{ème} jour est une élimination de la muqueuse de l'endomètre s'accompagnant d'hémorragie.

La sécrétion des hormones ovariennes : œstrogènes et progestérones est sous la dépendance des stimulines antéhypophysaires FSH et LH.

II. Les signes fonctionnels : peuvent être à type

- de douleurs,
- de pertes,
- d'hémorragies génitales et de troubles de la menstruation.

II.1. Les douleurs :

Évocatrices sont les douleurs pelviennes de siège hypogastrique et au niveau des fosses iliaques, à noter dans ces cas, la grande fréquence des douleurs lombaires associées.

-la dyspareunie est une douleur ressentie au niveau du vagin ou au niveau du petit bassin lors des rapports sexuels; elle peut être fonctionnelle ou révéler une affection organique.

-Dysménorrhée : règles douloureuses.

II. 2. Les pertes vaginales ou leucorrhées

Représentent un symptôme fréquent, correspondent à des écoulements vaginaux anormaux en rapport avec une infection génitale, basse ou haute. Elles sont à distinguer des leucorrhées physiologiques

II.2.1.Leucorrhées physiologiques

Les leucorrhées physiologiques proviennent :

- De la desquamation vaginale, responsable de leucorrhée laiteuse, peu abondante, opalescente, augmentant en période prémenstruelle ;
- De la glaire cervicale sécrétée par les cellules cylindriques de l'endocol qui augmente du 8^{ème} au 15^{ème} jour du cycle, translucide, cristallisant en feuille de fougère.

Ces sécrétions physiologiques n'engendrent aucune irritation, sont inodores et ne contiennent pas de polynucléaires.

Par ailleurs, le comportement compulsif d'hygiène intime excessive avec des savons détergents, peut entraîner une destruction de l'écosystème vaginal et favoriser la survenue d'infections génitales basses souvent chroniques.

Écosystème vaginal

Le vagin est un écosystème dynamique où chaque femme possède de nombreux micro-organismes en équilibre. La flore dominante est le bacille de Döderlein : lactobacille tapissant la muqueuse vaginale. Il transforme le glycogène abondamment contenu dans les cellules vaginales et cervicales grâce à l'imprégnation œstrogénique en acide lactique. Cet acide lactique explique le pH acide du vagin qui est un facteur protecteur de la pullulation microbienne.

Cette flore vaginale évolue selon :

- l'âge : moins de bacilles de Döderlein avant la puberté et après la ménopause ;
- le cycle : les aérobies diminuent avant et après les règles ;
- la contraception : en cas de stérilet, on constate une augmentation des anaérobies.

II.2.2. Les leucorrhées pathologiques

Tout ce qui pourra perturber cet équilibre favorisera le développement d'une flore pathogène, tout ce qui modifiera l'activité sécrétoire des cellules cervicales pourra être responsable de leucorrhées pathologiques et enfin toute perte provenant du haut appareil génital (endomètre, trompes, ovaires et pelvis) se caractérisera par des leucorrhées pathologiques.

1.Trichomonas

Les *leucorrhées* sont verdâtres, mousseuses, spumeuses, abondantes et nauséabondes (odeur de plâtre frais). Le prurit est variable en intensité, il existe souvent des brûlures au moment des rapports ou des mictions.

Au spéculum, le vagin est rouge, le col framboisé..

2. Mycose: Le Candida albicans

Le *sympôme* essentiel est une vulvo-vaginite prurigineuse. Intense, parfois intolérable, le prurit entraîne souvent une dysurie, voire une pollakiurie.

Au spéculum : les leucorrhées sont blanches, caillottes (comme du lait caillé), grumeleuses, tapissant les parois du vagin. La vulve est inflammatoire, œdémateuse avec de fréquentes lésions de grattage. L'extension sur le périnée postérieur est fréquente. Le vagin est rouge faisant ressortir le blanc des leucorrhées.

3. Vaginose bactérienne (VB)

La VB est un déséquilibre de la flore vaginale caractérisé où la flore lactobacillaire est remplacée par la prolifération anormale d'autres espèces microbiennes (anaérobies essentiellement).

Très fréquente elle est caractérisée par des pertes grises peu abondantes malodorantes.

L'examen au spéculum note peu d'irritation locale.

4. Gonocoque.

Les *leucorrhées* sont jaunes ou verdâtres, purulentes avec parfois des signes d'urétrite.

L'examen au spéculum trouve une cervicite avec glaire purulente, les parois vaginales sont rouges, saignant au contact. La notion d'urétrite chez le partenaire ou d'écoulement méatique doit faire penser au diagnostic.

5 . Mycoplasme, Chlamydia

Les leucorrhées sont inconstantes mais il existe habituellement une endocervicite, parfois discrète. *Chlamydia trachomatis* et *Mycoplasma genitalium* sont des infections sexuellement transmissibles fréquentes chez les 15–25 ans, souvent asymptomatiques mais responsables d'infection génitale haute

Tableau I : Récapitulatif des SymptomatoLOGIES .

	Leucorrhées	Signes locaux	Signes associés
<i>Candida</i>	Blanches, caséeuses	Prurit (+++++)	Vulvite (++) Anite (++)
Pyogènes	Purulentes	Brûlures	-
<i>Trichomonas</i>	Vertes, spumeuses	Prurit Brûlures	Urétrite Odeur de moisi
Vaginose bactérienne	Grisâtres, peu abondantes	Rare prurit ou irritation	Odeur de poisson pourri (sniff-test)

Bibliographie

1. Bianchi A. : Dépistage systématique des infections urogénitales à Chlamydia trachomatis, mythe ou réalité ? Revue Française des Laboratoires. 2003 Jan;2003(349-S1):39-42. - Support de Cours -
2. -Chaine B, Janier M. : Infections génitales. Encyclopédie Médico-Chirurgicale : Médecine d'urgence. 2009; 25-090-B-40.
3. Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), Conférence nationale des PU-PH en Gynécologie-Obstétrique. : Item 88 : Infections génitales de la femme – Leucorrhées. Issy-les-Moulineaux: Masson; 2006. p. 77-84.
4. Rose marie Hamladji. *Précis de Sémiologie, sémiologie de l'appareil génital*, pp 311-317
5. Baptiste Coustet. Sémiologie médicale, point important de l'anamnèse, PP363-4
6. Université Pierre et Marie Curie Gynécologie Niveau DCEM2 ; PP17- 19